

Trauma *a* psychoza

50–80% pacjentów z psychozą ma historię traumy. Trauma w dzieciństwie podwaja ryzyko psychozy. Pytanie o nią — nie pogarsza, a otwiera drogę do leczenia.

CZAS: 15 min · psychoedukacja Po stabilizacji · z terapeutą znającym traumę

ŹRÓDŁO: Varese i in. (2012, meta-analiza); Read i in. (2005); van den Berg i in. (2018, EMDR RCT)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum **dane o związku traumy z psychozą** (sekcja 1), poznaj cztery **typowe wzorce**, w których trauma odzwierciedla się w objawach (sekcja 2) i zobacz, jakie **terapie są bezpieczne** w psychozie (sekcja 3). Sekcja 4 — pytania, które warto omówić z terapeutą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Varese i in. (2012, meta-analiza 36 badań, ~80 000 osób): doświadczenie traumy w dzieciństwie **2,78x zwiększa ryzyko psychozy**. Wykorzystanie seksualne, przemoc fizyczna, zaniedbanie, świadkowanie przemocy, znęcanie psychiczne — każdy z tych czynników niezależnie podnosi ryzyko. Read i in. (2005, przegląd 51 badań): 50–80% pacjentów z psychozą ma historię traumy. **Treść objawów** (głosy, urojenia prześladowcze) często odzwierciedla traumę — głos krytycznego rodzica, paranoja u osoby, która rzeczywiście była śledzona. Trauma-informed care: *każdy pacjent powinien być spytany o traumę, delikatnie i z walidacją*.

01 = Dane o związku

2,78x

ryzyko psychozy po traumie w dzieciństwie (Varese, meta-analiza 2012). Każdy typ traumy podnosi ryzyko niezależnie.

50–80%

pacjentów z psychozą ma historię traumy (Read, 2005). Mimo to *znaczna mniejszość* jest pytana o nią w wywiadzie.

RCT BEZPIECZNE

van den Berg (2018, RCT z 155 pacjentami): EMDR i terapia ekspozycyjna *bezpieczne* w psychozie po stabilizacji — żaden epizod psychotyczny w grupie leczenia.

02 ☉ Cztery wzorce odzwierciedlenia traumy w objawach

GŁOS JAKO KRZYWDZICIEL

Głos mówi słowami krytycznego rodzica, prześladowcy. „*Jesteś bezwartościowy*” w tonie tego, kto to mówił dawniej. Chadwick (2006): często bezpośredni związek.

PARANOJA JAKO GENERALIZACJA

Po realnym zagrożeniu (przemoc, śledzenie) mózg uczy się traktować świat jako niebezpieczny. Urojenia prześladowcze rozwijają się jako *nadmierne uogólnienie*.

DYSOCJACJA JAKO MECHANIZM

Trauma uczy *oddzielania się od ciała i emocji*. To samo „*wycofanie z rzeczywistości*” pojawia się w niektórych formach psychozy. Moskowitz (2009): dysocjacja jest wspólnym mostem.

SCHIZOIDALNA ZBROJA

Wycofanie społeczne, spłaszczony afekt — pierwotnie ochrona przed kolejnym zranieniem. „*Lepiej nikogo nie wpuszczać*”. Objaw negatywny z genezą traumatyczną.

03 Terapie traumy bezpieczne w psychozie

Warunki bezpieczeństwa: stabilizacja farmakologiczna, doświadczony terapeuta, możliwość przerwania, plan działania w razie destabilizacji. Praca z traumą *jest możliwa* w psychozie, ale nie jest pierwszym krokiem.

EMDR ADAPTOWANE

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

van den Berg (2018, RCT): EMDR redukuje objawy PTSD i poprawia funkcjonowanie w psychozie. Bezpieczne po stabilizacji.

TF-CBT

Trauma-Focused CBT

Strukturyzowana terapia w 3 fazach: stabilizacja, przetwarzanie traumy, integracja. Adaptowana do tempa psychozy.

PRACA Z GŁOSAMI

CBTp + trauma lens

Gdy treść głosów odzwierciedla traumę — praca z głosami staje się jednocześnie pracą z traumą. Romme & Escher: bezpośrednia ścieżka.

04 Pytania do omówienia z terapeutą

Te pytania możesz przemyśleć przed sesją lub zabrać kartę na sesję. Nie musisz odpowiadać na wszystkie — wybierz to, co dziś czujesz, że możesz omówić.

CZY TREŚĆ MOICH OBJAWÓW MA ZWIĄZEK Z CZYMŚ, CO MNIE SPOTKAŁO?

— głosy, urojenia, lęki

CZY JESTEM GOTOWY/-A NA PRACĘ Z TRAUMĄ?

— czego potrzebuję, żeby zacząć

Klucz: stary mit — „nie wolno pytać pacjentów z psychozą o traumę, to ich destabilizuje” — został **obalony** przez RCT van den Berga (2018) i innych. Praca z traumą jest *nie tylko bezpieczna*, ale często **kluczowa** dla zdrowienia. Treść objawów ma *historię*. Zrozumienie tej historii nie „leczy” psychozy, ale **nadaje jej sens** i otwiera drogę: głos przestaje być przerażającą tajemnicą, staje się *zrozumiałą reakcją na to, co się stało*. Każdy pacjent ma prawo być spytany o traumę — delikatnie, z walidacją, w odpowiednim momencie.